

MACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 227310280

MAURICIO DA SILVA

IDADE: 78a PESO: 108 ALTURA: 170 PROFISSÃO: Motorista caminhão

SINTOMAS: Sonolência diurna / mmss edemaciado (após)

QUEIXAS: Garganta seca / esquecido

MEDICAMENTOS:

HAS / Prostrato / DM no limite / Colesterol ↑

MÉDICO: Dr. Cássio

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: 30' caminhada

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S 19:30

HORA QUE DORME: 21:30 HORA QUE ACORDA: 7:30

COCHILLO (X) SIM () NÃO 2h DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO esposa nunca

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 4x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: globosa CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 49.7 SPO2: 81%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Hernia umbilical

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA CA DE PROSTATA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: IMC: 39.4

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS Dor na perna

12/03/24 Avaliação no jélio desgate

19/03 P= 11.3

24 IAH= 4.1

M. de uso: 8h 12' Relata que houve melhora da sonolência, ↓ o edema de mmss.

flua

02/10/24 P= 8.4 cmH₂O

IAH= 6.4 e/h

mda jva: 6h 53'

fuq: 10.1/m

Está dormindo mais

tarde devido a programação de TV

Natacha

16/10/24 P= 9.2 cmH₂O

IAH= 4.4 e/h

mda jva: 9h 32'

fuq: 12.8 l/m

Melhorou el os horários de sono

Natacha

Orienta utilizar no sono da tarde também

19/11 P= 11.8 epm

24 IAH= 5.1 e/h

M. de uso: 10:37

flua cláudio

03/02 P= 8,8 cmH₂O P90% = 9,5 cmH₂O → online
2025 IAH = 2,7 e/h P90% = 11 cmH₂O → pendurir *está usando todo*
fuga = 12 l/min *dia após almoço*
muro = 40 h 25 (Auto 8 à 12 cmH₂O.) *Silvia*

28/02 P= 8,8 cmH₂O Auto 5 à 8 cmH₂O 12 cmH₂O
2025 IAH = 3,4 e/h
muro = 40 h 40' (dorme à tarde) ↓ 8 à 10 cmH₂O
fuga = 12 l/min *Silvia*

22/05/25 P= 8,6 cmH₂O *Beve adaptado*
IAH = 1,29 e/h *Natacha*
m de uso: 10 h 34'
fuga: 17,33 l/m

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: MAURICIO DA SILVA			
Sexo: M	Idade: 78 anos	Peso: 100 Kg	Altura: 1.70 m
Data do Exame: 24/05/2024		Exame: 13467_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 7:50:14 PM horas e encerrado às 6:01:08 AM horas, com latência para o sono de 13 minutos e latência para o sono REM de 582 minutos. O tempo total de sono foi de 587.0 minutos, com eficiência do sono de 95.7%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1.1%	Até 5%
Estágio 2	88.5%	45 - 55%
Estágio 3	8.3%	> 15%
Sono REM	2.1%	20 - 25%
Eficiência do sono	95.7%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 13 minutos ocorreram **476 despertares (índice de 48.7 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 52 bpm , a maior de 63 bpm e a menor de 47 bpm.

Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 486 eventos respiratórios, sendo 0 central, 486 obstrutivos e 0 misto. Sendo 336 apnéias, 150 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 49.7/hora**, sendo 34.3 apnéia/hora e 15.3 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 28.5 e a duração máxima de 58.9.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 86.4/hora, sendo 48.0 apnéia/hora e 38.4 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina foi de 95%**, sendo a saturação média de 92%, a maior de 98% e a mínima de 81%, permanecendo 92.9 minutos (15.1%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.0 minutos (0.0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 488 dessaturações. Índice de dessaturações: 50.9/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 14.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 52.0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Bruno de Andrade Soares
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 104075

CPAP